Препараты

Что показывать врачу в личном кабинете (схема лечения)

При выборе диагноза «Генерализованное тревожное расстройство» система должна выводить:

1. Рекомендуемые препараты 1-й линии + диапазоны доз (таблица выше).
2. Кнопку «Выбрать препарат» → врач указывает конкретный препарат + дозу + дату начала.
3. Автоматически подтягивается:
    - Ожидаемые сроки эффекта (4–6 недель).
    - Основные побочные эффекты выбранного препарата.
    - Что делать при непереносимости / отсутствии эффекта (следующий шаг алгоритма).
4. Поле «Текущая схема» + возможность отметить побочные эффекты, о которых сообщил пациент.
5. Напоминание о необходимости контроля (повторные шкалы, ЭКГ при необходимости, функция печени и т.д.).

Что показывать пациенту в личном кабинете

- Название препарата (международное + торговое, если врач указал).
- Как принимать (доза, время суток, с едой/без).
- **Важная информация:**
    - Эффект обычно развивается постепенно (не ждать мгновенного улучшения).
    - Возможные побочные эффекты (простым языком) + когда срочно обращаться к врачу.
    - Нельзя резко отменять самостоятельно.
- Кнопка «Сообщить о побочном эффекте» (список + свободный текст) → сразу видно врачу.
- График самочувствия (по шкалам) + напоминания о приёме.

Сделать дерево решений (алгоритм):
Диагноз ГТР → показать 1-ю линию.
Врач выбирает препарат → система показывает дозы, побочки, сроки оценки.
Через 4–6 недель: «Эффект есть / частичный / нет / непереносимость» → предлагает следующий шаг по КР.
Всегда оставлять поле «Индивидуальное решение врача» (чтобы не создавать иллюзию, что система назначает).

Как лучше показывать пациенту на сайте - побочки об его препарате

Рекомендую сделать два уровня:

1. Кратко (в карточке препарата):
○ «Возможные частые побочные эффекты: тошнота, головная боль, сонливость/бессонница, снижение либидо. В первые 1–2 недели возможно временное усиление тревоги».
2. Подробно (по кнопке «Подробнее о побочных эффектах»):
○ Разбивка по частоте + что делать, если появился эффект (обратиться к врачу / не отменять резко и т.д.).

Для пациента в ЛКО - типичные побочные эффекты

Святая святых - АВИАНДР)))))))
Применение: ГТР
Прием: внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки
ПЭ: Возможные частые побочные эффекты: головная боль, головокружение, сонливость, слабость, ощущение покалывания.
Реже могут появляться: снижение аппетита, бессонница или усиление тревоги, тошнота, потливость, мышечная скованность

Группа препаратов	ПЭ
СИОЗС (Пароксетин, Эсциталопрам, Сертралин, Циталопрам, Флуоксетин, Флувоксамин)	Частые: ● Тошнота, снижение аппетита ● Головная боль ● Бессонница или, наоборот, сонливость ● Сухость во рту ● Потливость ● Тревога/возбуждение в первые 1–2 недели (особенно важно предупредить!) ● Снижение либидо, задержка оргазма ● Дрожь, чувство внутреннего напряжения Менее частые, но важные: ● Увеличение или снижение веса ● Диарея или запоры ● Головокружение ● Серотониновый синдром (при комбинации с другими препаратами) — редко
СИОЗСН (Венлафаксин, милнаципран, дулоксетин)	Частые: ● Тошнота ● Головная боль ● Повышение артериального давления (особенно в высоких дозах) ● Бессонница ● Потливость ● Сухость во рту ● Снижение аппетита ● Сексуальные нарушения Особенности: ● При резкой отмене — выраженный синдром отмены (головокружение, «электрические разряды», раздражительность)
Трициклические антидепрессанты (амитриптилин, имипрамин, мапротилин, кломипрамин)	Частые: сухость во рту, запоры, сонливость, увеличение веса, нарушение зрения, ортостатическая гипотензия, проблемы с мочеиспусканием, влияние на сердце (нужен контроль ЭКГ).
Бензодиазепины (Алпразолам, Клоназепам, Лоразепам, Диазепам)	Частые: ● Сонливость, заторможенность ● Снижение концентрации внимания ● Мышечная слабость ● Головокружение ● Нарушение координации Важные риски: ● Формирование зависимости (особенно при длительном приёме) ● Синдром отмены (тревога, бессонница, раздражительность, в тяжёлых случаях — судороги) ● Ухудшение памяти ● Парадоксальные реакции (возбуждение, агрессия) — редко

Миртазапин	Частые: сильная сонливость (особенно в начале), увеличение веса и аппетита, сухость во рту, головокружение
Агомелатин	Обычно хорошо переносится. Возможны: головная боль, тошнота, головокружение, повышение печёночных ферментов (нужен контроль анализов).
Вортиоксетин	Частые: тошнота (особенно в начале), запоры, рвота, головокружение.
Гидроксизин - он же Атаракс - анксиолитик	Частые: ● Сонливость ● Сухость во рту ● Слабость ● Головокружение Реже: ● Нарушение аккомодации (затуманивание зрения) ● Задержка мочеиспускания ● Аллергические реакции
Прегабалин и Габапентин - противоэпилептические препараты	Частые: ● Головокружение ● Сонливость ● Отёки (особенно ног) ● Увеличение веса ● Нарушение внимания и концентрации ● Сухость во рту ● Тремор Реже: ● Эйфория или, наоборот, раздражительность ● Нарушения зрения
Атипичные антипсихотики (низкие дозы) (Кветиапин, Сульпирид)	Кветиапин: ● Сонливость ● Сухость во рту ● Головокружение ● Увеличение веса ● Ортостатическая гипотензия (падение давления при вставании) ● Запоры Сульпирид: ● Повышение пролактина (нарушения менструального цикла, галакторея, снижение либидо) ● Сонливость или, наоборот, бессонница ● Тревога/беспокойство в начале лечения ● Экстрапирамидные симптомы (редко в низких дозах)

ГТР - F41.1

Для пациента в ЛКО - типичные побочные эффекты

СИОЗС / СИОЗСН (общие):

- Тошнота, снижение аппетита / набор веса
- Нарушения сна или сонливость
- Головная боль, головокружение
- Сексуальные нарушения
- Потливость, тремор
- В начале терапии возможно временное усиление тревоги

Прегабалин: головокружение, сонливость, отёки, увеличение веса.
Агомелатин: головная боль, тошнота, повышение печёночных ферментов (нужен контроль).
Бензодиазепины: сонливость, привыкание, нарушение координации.

Терапия первой линии

Когда: сразу после установления диагноза ГТР

Цель - снижение интенсивности тревоги и стабилизация состояния

Препарат	Рекомендуемая доза (мг/сут)	Примечания
Эсциталопрам	10–20	Хорошая переносимость
Пароксетин	20–40	Сильный анксиолитический эффект
Сертралин	50–200	Широкий диапазон доз
Венлафаксин	75–225	СИОЗСН, удобен при сопутствующей депрессии
Дулоксетин	30–120	Хорош при соматических симптомах
Агомелатин	25–50	Принимается на ночь
Прегабалин	150–600	Предпочтителен при преобладании соматических эквивалентов тревоги

Дополнительно на 1-й линии:

- При выраженной тревоге и вегетативных нарушениях — краткосрочное (обычно 2–4 недели) назначение производных бензодиазепина (только при отсутствии риска злоупотребления ПАВ).
- Можно комбинировать антидепрессант + бензодиазепин в начале терапии.

Оценка эффекта: через 4–6 недель. При частичном ответе — продолжить до 12 недель.

Терапия второй линии

Основания для перехода:

- Отсутствие достаточного эффекта после адекватного курса 1-й линии (4–6, максимум 12 недель).
- Плохая переносимость препарата 1-й линии.
- Частичный ответ (нужно усилить терапию).

Что делать:

1. Убедиться в комплаентности пациента.
2. Довести дозу текущего препарата до максимально переносимой.
3. Сменить на другой препарат из списка 1-й линии (не использовавшийся ранее).
4. Перейти на монотерапию прегабалином (если ещё не применялся).
5. Присоединить бензодиазепин на более длительный срок (с осторожностью).
6. Назначить препараты 2-й линии.

Препарат / подход	Доза (мг/сут)	Комментарий
Имипрамин	50–200	ТЦА
Кломипрамин	50–250	ТЦА
Буспирон	15–60	
Гидроксизин	50–100	
Кветиапин	50 → 150–300	Начинать с 50 мг, повышать постепенно
Комбинация СИОЗС/СИОЗСН + прегабалин	Прегабалин 150–600	Часто используется

Терапия третьей линии

Основания для перехода:

- Неэффективность или непереносимость препаратов/подходов 1-й и 2-й линии.

Вариант	Доза / схема	Комментарий
Комбинация антидепрессанта (СИОЗС или венлафаксин/дулоксетин) + прегабалин	Прегабалин 150–600 мг/сут	Один из основных вариантов
Имипрамин	75–200 мг/сут	
Кветиапин	Начало 50 мг → 150 мг на 3-й день → до 300 мг к 3–4 неделе	Учитывать метаболические побочные эффекты
Гидроксизин	50–100 мг/сут	При рефрактерности к предыдущим линиям

Терапия четвёртой линии (терапевтическая резистентность)

Основания:

- Неэффективность первых трёх этапов психофармакотерапии.

Обязательные действия перед назначением:

- Уточнение диагноза
- Выявление коморбидных расстройств
- Дополнительное обследование
- Оценка комплаентности

Возможные варианты (по КР):

- Антипсихотики второго поколения (чаще в комбинации с антидепрессантами):
    - Оланзапин + флуоксетин (оланзапин начинают с 2,5 мг, повышают до 20 мг)
    - Другие атипичные антипсихотики (арипипразол, рисперидон в низких дозах и др.)
- Вальпроевая кислота 1500 мг/сут (разделить на 3 приёма)
- Другие антидепрессанты: вортиоксетин 2,5–10 мг, кломипрамин 50–250 мг, циталопрам и др.
- Комбинированная терапия по решению врача

Паническое расстройство F41.0

Важные особенности при паническом расстройстве (отличия от ГТР)

- Бензодиазепины используются чаще и активнее на старте (для купирования атак), но строго коротким курсом.
- Предпочтительнее начинать именно с СИОЗС, а не с венлафаксина.
- Титрация доз обычно более осторожная (начинают с низких доз, особенно пароксетин и эсциталопрам).
- Поддерживающая терапия 6–12 месяцев в той же дозе.
- Бензодиазепины — не дольше 6 месяцев

Терапия первой линии

Когда применяется: сразу после установления диагноза панического расстройства (F41.0).
Цель: снижение общей тревожности, уменьшение частоты и интенсивности панических атак.

Препарат	Рекомендуемая доза (мг/сут)	Примечания
Эсциталопрам	Начало 5 мг → 10–20	Предпочтительный старт с низкой дозы
Пароксетин	Начало 10 мг → 20–60	Повышать по 10 мг в неделю
Сертралин	50–200	
Циталопрам	20–60	
Флуоксетин	20–60	
Флувоксамин	100–300	
Венлафаксин	75–225	СИОЗСН (несколько хуже переносимость, чем СИОЗС)

Дополнительно на 1-й линии (почти всегда):

- Краткосрочный курс бензодиазепинов (2–4 недели, особенно при частых атаках):
  - Клоназепам 0,25–4 мг
  - Лоразепам 1–7,5 мг
  - Алпразолам 0,75–6 мг
  - Диазепам 5–10 мг

Эффект антидепрессантов развивается постепенно (обычно 2–8 недель), поэтому бензодиазепины используют в начале для быстрого контроля симптомов.

Длительность поддерживающей терапии после достижения эффекта: 6–12 месяцев.

Терапия второй линии

Основания для перехода:

- Недостаточный эффект после адекватного курса 1-й линии (обычно 4–6–8 недель).
- Плохая переносимость.
- Частичный ответ.

Что делают:

1. Повышают дозу текущего препарата до максимальной переносимой.
2. Меняют на другой препарат 1-й линии (СИОЗС ↔ венлафаксин).
3. Продлевают/добавляют бензодиазепины.
4. Переходят на препараты 2-й линии.

Препарат / группа	Доза (мг/сут)	Комментарий
Кломипрамин	50–150	ТЦА
Имипрамин	25–200	ТЦА
Миртазапин	15–30 (до 45)	
Дулоксетин	60–120	
Милнаципран	50–100	
Габапентин	600–3600	Противоэпилептический
Вальпроевая кислота	500–3000	

Терапия третьей линии / при резистентности

Основания: отсутствие эффекта от 1-й и 2-й линии.

Возможные варианты (по КР и алгоритмам):

- Комбинации антидепрессантов.
- Добавление антипсихотиков 2-го поколения в низких дозах:
    - Арипипразол 5–30 мг
    - Рисперидон 0,25–3 мг
    - Оланзапин 2,5–20 мг
- Противоэпилептические препараты (габапентин, вальпроат) в более высоких дозах или комбинациях.
- Другие стратегии по решению врача (включая усиление психотерапии).

Тревожно-фобическое расстройство F40

Важная особенность ТФР В отличие от ГТР и панического расстройства, психотерапия здесь имеет приоритет (особенно КПТ). Фармакотерапия применяется чаще при частых/интенсивных проявлениях, выраженном избегании или недостаточной эффективности психотерапии.

Терапия первой линии

Когда применяется:

- При социальных фобиях и агорафобии с частыми и/или интенсивными проявлениями.
- При специфических фобиях — если проявления частые и интенсивные.

Препарат	Рекомендуемая доза (мг/сут)	Примечания
Пароксетин	20–40	
Эсциталопрам	10–20	
Сертралин	50–200	
Циталопрам	20–40	
Венлафаксин	75–225	СИОЗСН

Для быстрого эффекта (особенно в начале):

- Гидроксизин 25–100 мг/сут
- Короткий курс бензодиазепинов (3–4 недели):
    - Алпразолам 0,5–0,75 мг
    - Клоназепам 0,5–3 мг

При специфических фобиях (если симптомы частые): чаще эсциталопрам 10–20 мг или пароксетин 20 мг.
При редких столкновениях с объектом страха (например, полёт 1–2 раза в год) — только ситуационные бензодиазепины.

Терапия второй линии / усиление

Основания для перехода:

- Частичный или недостаточный ответ на 1-ю линию.
- Плохая переносимость.

Варианты:

1. Повышение дозы текущего препарата.
2. Смена на другой препарат 1-й линии.
3. Комбинация психотерапии + СИОЗС/СИОЗСН.
4. Добавление препаратов усиления.

Препарат / группа	Доза (мг/сут)	Комментарий
Прегабалин	150–600	
Габапентин	900–3600	
Кветиапин	50–400	Постепенное повышение
Сульпирид	50–400	
Миртазапин	30–45	
Агомелатин	25–50	
Тразодон	50–200	

Терапия при недостаточной эффективности / резистентности

- Комбинации антидепрессанта + антипсихотика (сульпирид, кветиапин).
- Противоэпилептические препараты (прегабалин, габапентин) в более высоких дозах.
- Более интенсивная психотерапия + фармакотерапия.
- В отдельных случаях — другие антидепрессанты или комбинированные схемы по решению врача.

Длительность терапии

- Антидепрессанты: обычно 6–12 месяцев в эффективной дозе после достижения улучшения.
- Бензодиазепины: коротко (не более нескольких недель, максимум до 6 месяцев с большой осторожностью).
- Отмена — постепенно.

Краткая схема алгоритма (по Приложению Б КР)

1. Гидроксизин или бензодиазепин для быстрого купирования.
2. Основная терапия — СИОЗС / венлафаксин (± психотерапия).
3. При частичном ответе → смена препарата 1-й линии или комбинация.
4. При отсутствии эффекта → добавление кветиапина / сульпирида / прегабалина / габапентина.

Депрессивные расстройства: Депрессивный эпизод F32 И Рекуррентное депрессивное расстройство F33

Первая линия (1-й этап)

Лёгкая степень (F32.0 / F33.0):

- СИОЗС
- Агомелатин
- Вортиоксетин

Средняя степень (F32.1 / F33.1):

- СИОЗС
- СИОЗСН (венлафаксин, дулоксетин)
- Миртазапин
- Агомелатин
- Вортиоксетин

Тяжёлая степень без психотических симптомов (F32.2 / F33.2):

- Предпочтительнее препараты с более широким механизмом: СИОЗСН, миртазапин, ТЦА
- СИОЗС и новые АД — второй выбор

Рекомендуемые дозы (из Приложения А3 КР):

Препарат	Стартовая доза (мг/сут)	Диапазон доз (мг/сут)
Эсциталопрам	10	10–20
Пароксетин	20	20–50
Сертралин	50	50–200
Циталопрам	20	20–40
Флуоксетин	20	20–80
Флувоксамин	50–100	100–300
Венлафаксин	75	75–375 (в стационаре > 225)
Дулоксетин	60	60–120
Миртазапин	15–30	15–45
Агомелатин	25	25–50
Вортиоксетин	10	10–20
Амитриптилин	50–75	150–300
Имипрамин	25–75	150–300
Кломипрамин	50–75	100–250

Эффект обычно оценивают через 3–4 недели (иногда до 6–8 недель для СИОЗС). При недостаточном эффекте — повышают дозу.

Вторая линия (2-й этап)

- Повышение дозы до максимальной переносимой
- Смена антидепрессанта (внутри класса или на другой механизм)
- Переход на парентеральное введение (для некоторых ТЦА)

Третья линия (3-й этап) — аугментация / комбинации

- Комбинации АД с комплементарными механизмами
- Аугментация атипичными антипсихотиками:
    - Кветиапин (старт 50 мг → до 300 мг)
    - Арипипразол (старт 5 мг → до 15 мг)
    - Оланзапин (+ флуоксетин)
    - Рисперидон
- Добавление лития, ламотриджина и др.

Четвёртая линия / резистентность

- Электросудорожная терапия (ЭСТ)
- Другие методы аугментации
- Комбинации + психотерапия

При тяжёлой депрессии с психотическими симптомами — сразу АД широкого спектра + антипсихотик 2-го поколения.

Длительность поддерживающей терапии после ремиссии: минимум 6 месяцев (при рекуррентном — часто дольше, 1–2 года и более).